

COMO PENSAR

Cortical

Amnésia s/ pistas +
afasia/apraxia/agnosia (AD, FTD)

Subcortical

Lentidão+executivo; memória COM
pistas; humor/movimento (vascular,
DCL, HPN)

Excluir imitadores

Delirium (agudo), depressão
(melhora c/ pistas), reversíveis

CONFRONTOS

AD × Vascular

lento/hipocampo × degraus/lacunas;
memória sem×com pistas

AD × DCL

DCL: flutuação + alucinação visual +
parkinson + REM (não dar
neuroléptico típico)

FTD × psiquiátrico

conduta/desinibição <65, memória
poupada, atrofia frontal

RÁPIDAS & IMAGEM

Rápida (sem-meses)

DCJ: DWI cortical, RT-QuIC, EEG; +
autoimune/tratável

Red flags

jovem, focal, mioclonia, quedas precoces →
investigar/encaminhar

Imagem dirime

hipocampo=AD · lacunas=vascular ·
frontal=FTD · DWI=DCJ · DESH=HPN

DECISÃO & CONDUTA

Árvore

excluir reversível → rápido? →
cortical/subcortical → subtipo

Conduta muda

anticolinest. (AD/DCL) · fatores
(vascular) · DVP (HPN)

Segurança

DCL: evitar neuroléptico típico. No
idoso: pense MISTA

A RÉGUA

1) cortical ou subcortical? (teste das pistas) 2) a 1ª queixa e o curso 3) a imagem confirma. Excluir o reversível e o rápido vem ANTES de classificar o degenerativo.

ALERTAS

- **DCL:** cautela/evitar neurolépticos típicos.
- **HPN:** cognição+marcha+incontinência → reversível.
- **Rápida:** investigar com urgência (DCJ × tratável).